



PROPUESTA DE ARTÍCULO · FUERA DE BATA

TÍTULO PENDIENTE DE ELEGIR

Una revisión de la literatura internacional sobre psicosis y suicidio encuentra que el riesgo no lo marca el síntoma más grave. Lo marca lo que le pasa a la persona alrededor del diagnóstico, y varios hallazgos de esa revisión contradicen bastante el sentido común.

Alberto Martín Montero

Máster de Psicología General Sanitaria · Universidad de Oviedo

Salud Mental

11 min de lectura

Fuera de Bata

SALUD MENTAL

11 min de lectura

TÍTULO PENDIENTE

A alguien le diagnostican un trastorno psicótico y, los primeros días, no está solo. Hay ingreso, hay médicos pendientes, hay familia mirando el teléfono. El problema llega después, cuando ese acompañamiento se relaja y la persona se queda a solas con todo lo que ese diagnóstico acaba de cambiarle la vida. Una revisión de la literatura científica sobre psicosis y suicidio pone cifras a ese momento exacto, y de paso desmonta varias ideas muy asentadas sobre qué es lo que empuja de verdad a alguien al suicidio. Empecemos por la que más se repite, y la que menos se sostiene en cuanto se mira de cerca.

El mito que sostiene buena parte del discurso sobre salud mental

Se repite tanto que nadie lo cuestiona. El 90% de las personas que mueren por suicidio tenía un trastorno mental, dice la idea instalada. Los estudios de autopsia psicológica más recientes en España la rebajan al 45%, casi la mitad. Alberto Martín Montero, del Máster de Psicología General Sanitaria de la Universidad de Oviedo, revisó 42 estudios internacionales publicados entre 2014 y 2024 para ir un paso más allá de esa cifra. No preguntó si tener un diagnóstico de psicosis empuja al suicidio. Preguntó qué es, dentro de la vida real de una persona, lo que dispara ese riesgo y qué lo frena.

Entre un 5% y un 15% de las personas con psicosis muere por suicidio. Una de cada cuatro, aproximadamente, lo ha intentado alguna vez. Son cifras que asustan, y con razón. Pero se quedan cortas si no se mira también cuándo ocurre, porque el riesgo no se reparte igual a lo largo de la enfermedad. Se concentra, y mucho, en un momento muy concreto, y ese momento no es el que la mayoría imaginaría.

El momento que nadie vigila lo suficiente

Lo más repetido en los 42 estudios no tiene que ver con las alucinaciones ni con los delirios. Tiene que ver con lo que ocurre justo después de recibir el diagnóstico. El primer episodio y el año que le sigue son, con diferencia, el momento de mayor riesgo, porque es cuando alguien tiene que asumir de golpe una vida distinta. Medicación con efectos que casi nunca se explican bien del todo. A veces un ingreso. Y casi siempre el peso de cómo empiezan a mirarlo los demás a partir de ese momento. Haber consumido cannabis o alcohol, y haber vivido una infancia dura, multiplican ese riesgo. Y casi siempre aparece al lado la depresión, formando parte del mismo agotamiento más que actuando como un diagnóstico aparte.

Hay un matiz en la revisión que rara vez se cuenta, y que complica todavía más la fotografía. No todas las muertes que se registran como suicidio en personas con psicosis significan lo mismo. No es igual morir por escapar de unas voces que ordenan hacerse daño, donde ni siquiera está claro que haya una intención real de morir, que decidir poner fin al sufrimiento que provocan los efectos del propio tratamiento, semanas o meses después, con la cabeza fría. Son dos historias distintas metidas dentro de

la misma estadística. Confundirlas tiene consecuencias directas en cómo se intenta prevenir cada una, y quizás explica por qué las cifras varían tanto de un estudio a otro.

Cuando cuidar de más también hace daño

Hay otro hallazgo incómodo en la revisión, y tiene que ver con cómo se trata a estas personas dentro del propio sistema sanitario. Existe un tipo de estigma que casi nunca se nombra, distinto al que viene de fuera. Se llama iatroestigma y se refiere a las conductas sobreprotectoras y limitantes que ejerce el propio personal sanitario, la sobreprotección, la sobremedicación, la restricción de libertad, el papel de experto que decide por la persona en vez de con ella. Nace de la mejor intención, evitar que alguien se haga daño, pero el efecto es justo el contrario. Cuando a alguien se le quita la capacidad de decidir sobre su propia vida, aumenta la sensación de indefensión, y esa indefensión es uno de los caminos directos hacia el sufrimiento que termina en conducta suicida.

La revisión describe varios tipos de estigma que se retroalimentan entre sí, y que rara vez se separan al hablar del tema. Está el que viene de las instituciones y sus normas. Está el que viene de la gente de alrededor, con sus prejuicios y su incomodidad. Está el que la propia persona termina interiorizando hasta convertirlo en vergüenza hacia sí misma. Y está el iatroestigma, que nace dentro del propio sistema que se supone que ayuda. Cuando los cuatro se juntan, lo que queda no es solo alguien con síntomas que tratar. Es alguien a quien casi nadie, ni siquiera quien lo cuida, termina tratando como una persona capaz de decidir sobre su vida.

El mismo patrón aparece en los datos sobre la familia. La cohesión familiar protege, y mucho, salvo en un caso muy concreto, cuando la persona siente esa vergüenza intensa hacia sí misma por su diagnóstico. Ahí, incluso una familia unida puede no ser suficiente. Lo que de verdad parece amortiguar el riesgo no es solo tener gente alrededor. Es que esa gente trate a la persona como alguien capaz de decidir, no como alguien al que hay que vigilar. Y esto conecta con otro hallazgo de la revisión que tampoco encaja con lo que cualquiera esperaría.

Los datos que no encajan con el sentido común

Un mayor nivel de inteligencia se asocia a más riesgo de suicidio, no a menos, según tres de los estudios analizados. Es un dato que choca de entrada, porque la intuición dice justo lo contrario. Y hay otro todavía más difícil de digerir. Darse cuenta con claridad de lo que está pasando, lo que en clínica se llama insight, puede aumentar el riesgo justo al principio del trastorno, aunque con el tiempo termine convirtiéndose en un factor de protección.

La explicación que propone el trabajo tiene sentido en cuanto se piensa un momento. Entender con precisión que tu vida acaba de cambiar para siempre, que vas a necesitar medicación, que la gente te va a mirar distinto, no es un alivio inmediato. Es la peor noticia posible, procesada con total lucidez. La rabia, la desesperanza y el duelo llegan antes que la aceptación. Cuanta más capacidad tiene alguien para entender la magnitud de lo que le está pasando, más doloroso resulta ese primer tramo.

Hay un tercer dato que tampoco cuadra del todo, y tiene que ver con el sexo. En la conducta suicida en general, las mujeres intentan quitarse la vida más veces, pero son los hombres quienes mueren con más frecuencia al hacerlo. En la revisión sobre psicosis aparece la misma paradoja mezclada con resultados que se contradicen entre estudios, unos encuentran más riesgo en mujeres, otros en hombres. La

explicación más plausible no es biológica. Es de método. Los hombres suelen elegir formas más letales, y eso significa que sobreviven menos veces para poder ser contados entre los intentos.

Lo único que parece funcionar, y lo mucho que queda por probar

Con tanto dato apuntando hacia lo mismo, que el entorno pesa más que el diagnóstico, cabría esperar que la prevención se centrara ahí. No del todo. En protección, lo que más se repite no es un fármaco milagroso. Es el apoyo social y la conexión con otras personas. El único tratamiento con evidencia sólida es la clozapina, un antipsicótico que solo se receta cuando otros dos ya han fallado, pero incluso ahí el trabajo señala algo incómodo. Nadie sabe si el efecto viene del fármaco en sí o del seguimiento médico mucho más estrecho que recibe quien lo toma, con revisiones frecuentes y contacto constante con su equipo.

Ninguno de los 42 estudios analizó la psicoterapia como opción principal, pese a ser la alternativa que, según esta revisión, sale mejor parada al comparar riesgos y beneficios. Es un hueco llamativo. Casi toda la inversión en investigación se ha ido hacia lo que se puede medir con una pastilla, no hacia lo que exige tiempo y personas, escuchar, acompañar, no soltar a alguien justo cuando más solo se siente. Y eso es, estudio tras estudio, lo que más se repite del lado de la protección. Tener a alguien cerca que no desaparezca.

La misma materia

Todo esto conecta con una idea que atraviesa el trabajo entero, y que quizás sea la más importante de todas. Los factores de riesgo del suicidio y los factores de riesgo de la psicosis se parecen tanto (el aislamiento, el trauma en la infancia, la falta de apoyo, la sensación de no tener salida) que probablemente estén hechos de la misma materia. No de un trastorno que hay que curar, sino de un sufrimiento muy concreto que alguien intenta dejar de sentir, por cualquier vía que encuentre a mano. Puesto así, la pregunta deja de ser qué tiene esa persona. Pasa a ser qué le ha pasado.

«Es imprescindible repensar la psicosis en un marco fenomenológico contextual que trabaje tomando en cuenta a la persona y sus circunstancias, y no se centre en reducir síntomas.»

Alberto Martín Montero, Universidad de Oviedo (2025)

Si conoces a alguien a quien acaban de diagnosticar un trastorno psicótico, el momento en que más te necesita no es forzosamente la crisis aguda. Es después, cuando ya ha pasado lo peor de puertas afuera pero está solo por dentro, asumiendo lo que ese diagnóstico cambia en su vida. Ayudar no significa vigilar cada paso ni decidir por esa persona. Significa acompañar sin quitarle las riendas. Preguntar, acompañar y no desaparecer pesa, según este trabajo, más que casi cualquier otra cosa. Y si tú o alguien cercano está teniendo pensamientos de este tipo, el **024** (Atención a la Conducta Suicida, gratuito y 24 horas) existe exactamente para eso.

Fuente: **Martín Montero (2025)**, TFM, Universidad de Oviedo · *enlace al repositorio pendiente de confirmar con el autor*

Antes de publicar

Este documento es una propuesta de trabajo. Nada de lo anterior sale a lainferencia.com sin que se cumplan estos tres puntos.

☐

Revisión del contenido y elección de título

Lectura completa del artículo, conformidad con cómo se presentan los datos del TFM, y elección de uno de los títulos propuestos por correo (o una alternativa).

☐

Crédito y enlace a la fuente

Se confirma si el TFM está depositado en el repositorio de la Universidad de Oviedo (RUO) para enlazarlo como fuente pública, o si se cita como "TFM inédito" mientras tanto.

☐

Aprobación explícita por escrito

Confirmación por correo o mensaje de que se autoriza la publicación en la sección Fuera de Bata de La Inferencia.

Alberto Martín Montero · fecha

Miguel Noguea Escudero · fecha